

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE EXPERIENCIA SEXUAL DE ARIZONA (ASEX)

Eje VI: Conducta de Salud y Sexualidad • Detección Breve de Disfunción Sexual de McGahuey

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Experiencia Sexual de Arizona (ASEX; versión masculina y femenina).
Nombre Original	Arizona Sexual Experience Scale (ASEX; McGahuey et al., 2000; University of Arizona).
Autores Originales	C. A. McGahuey, M.D., F. J. Delgado, F. A. Moreno, R. Laukes, M. J. Gelenberg y P. L. Delgado.
Adaptaciones Hispanas	García-Portilla et al. (2005); Bobes et al. (2002); Rodríguez-Bailón et al. (2012).
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Somática y Sexualidad. Disfunción sexual en las distintas fases del ciclo erótico.
Tipo de Instrumento	Cuestionario breve de autoinforme estructurado (o administrado en entrevista clínica).
Composición de Ítems	5 reactivos evaluados en escala tipo Likert de 6 puntos (1 a 6; rango 5 a 30 puntos).
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años); validado en depresión, esquizofrenia y población comunitaria.
Tiempo de Administración	2 a 3 minutos de rápida cumplimentación en consulta ambulatoria o de hospitalización.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y proyectos de investigación académica sin fines de lucro.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL CICLO DE RESPUESTA SEXUAL BREVE

La **ASEX** fue creada en la Universidad de Arizona para solventar la ausencia de herramientas ágiles y psicométricamente robustas en la práctica psiquiátrica:

- Mapeo Completo del Ciclo Erótico:** Abarca en solo 5 ítems las etapas descritas por Masters, Johnson y Kaplan: impulso/deseo, excitación psicológica subjetiva, respuesta fisiológica vasocongestiva (erección en varones / lubricación en mujeres), latencia orgásmica y satisfacción con el orgasmo.
- Sensibilidad a Psicofármacos:** Muy sensible para documentar el impacto iatrogénico de antidepresivos serotoninérgicos (ISRS/ IRSN) y antipsicóticos sobre la función sexual.
- Neutralidad Moral y Accesibilidad:** Utiliza un fraseo neutro, directo y no invasivo que minimiza la incomodidad del paciente durante la cumplimentación.

3. LOS 5 REACTIVOS CARDINALES DEL PROTOCOLO ASEX

Fase del Ciclo Sexual	Rango	Definición Operativa del Reactivo Clínico
1. Deseo Sexual / Libido	1 a 6 puntos	Frecuencia e intensidad del impulso o apetito sexual en la última semana.
2. Excitación Psicológica	1 a 6 puntos	Facilidad subjetiva para excitarse o responder ante estímulos sexuales.
3. Respuesta Fisiológica	1 a 6 puntos	Erección fácil y mantenida (hombres) o lubricación vaginal adecuada (mujeres).
4. Facilidad del Orgasmo	1 a 6 puntos	Habilidad para alcanzar el orgasmo o clímax sin retraso indebido.
5. Placer del Orgasmo	1 a 6 puntos	Nivel de satisfacción, plenitud y gratificación física tras alcanzar el orgasmo.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones clínicas hispanas (García-Portilla et al., 2005; Rodríguez-Bailón et al., 2012; $N > 650$) confirman su solidez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.89 - 0.93	Excelente homogeneidad psicométrica en una escala breve de 5 ítems.
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.89$ (a 1 semana)	Gran estabilidad temporal en ausencia de modificaciones farmacológicas.
Sensibilidad Diagnóstica	Sensibilidad = 91%	Detección precisa de disfunción sexual inducida por antidepresivos.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 88%	Distingue eficazmente personas sin patología de disfunción clínica.
Validez Concurrente	$r = 0.76$ con CSFQ-14	Fuerte correlación convergente con escalas extensas de sexualidad.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CRITERIOS OPERATIVOS DE MCGAUHEY

- **Opciones de Puntuación:** Cada ítem se puntúa de 1 a 6 (donde 1 representa una función excelente y 6 representa ausencia total de función o incapacidad absoluta).

- **Cálculo de la Puntuación Total ASEX:**

$$\text{Puntuación Total ASEX} = \sum_{i=1}^5 \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 5 a 30 puntos})$$

- **Criterios Diagnósticos de Disfunción Sexual de Arizona (McGahuey et al., 2000):**

Se establece el diagnóstico de **Disfunción Sexual Clínica** si se cumple **cualquiera** de las siguientes tres condiciones:

$$\text{Disfunción Sexual Positiva} \Leftarrow \begin{cases} 1. \text{Puntuación Total ASEX} \geq 19 & (\text{Puntuación global elevada}) \\ 2. \text{Algún ítem individual} \geq 5 & (\text{Disfunción severa en una fase}) \\ 3. \text{Tres o más ítems individuales} \geq 4 & (\text{Disfunción moderada generalizada}) \end{cases}$$

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Criterio Ítems	Estado Clínico y Significación Funcional (McGahuey)
Excelente / Normal	5 a 12 puntos	Todos ≤ 2	Función sexual plenamente satisfactoria en todas las fases.
Función Aceptable	13 a 18 puntos	Todos ≤ 3	Variabilidad normativa sin criterio patológico; quejas menores esporádicas.
Disfunción Leve	19 a 22 puntos	Tres ítems ≥ 4	Punto de corte clínico disfunción sexual manifiesta.
Disfunción Severa	23 a 30 puntos	Varios ítems ≥ 5	Colapso sexual severo anorgasmia o impotencia completa.

TRIPLE CRITERIO DIAGNÓSTICO CANÓNICO DE ARIZONA (ASEX ≥ 19):

La gran ventaja de la ASEX reside en su **triple criterio sensible**: no solo captura la afectación global (**Total ≥ 19**), sino que identifica a pacientes con deseo conservado pero bloqueo orgásmico farmacológico selectivo (**Ítem 4 = 5 o 6**), protegiendo contra el subdiagnóstico de quejas focales graves.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE DISFUNCIÓN SEXUAL EN SALUD MENTAL

PROTOCOLO DE MANEJO ASISTENCIAL CON LA ESCALA ASEX:

- **Paso 1 (Administración Rutinaria en Consultas de Psicofarmacología):** Entregar la escala en sala de espera o administrarla directamente en consulta tras 4 semanas de iniciar antidepresivos o antipsicóticos.
- **Paso 2 (Análisis del Patrón por Criterios McGahuey):**
 - Si Total < 19 y ningún ítem $\geq 5 \rightarrow$ Función sexual preservada o tolerada; mantener tratamiento.
 - Si ítem 1 y 2 elevados con 3, 4 y 5 normales $\rightarrow$ Pérdida de deseo primaria por episodio depresivo mayor activo (falta de motivación global).
 - Si ítem 1 normal (deseo presente) pero ítem 4 y 5 ≥ 5 (anorgasmia completa) $\rightarrow$ **Efecto secundario serotoninérgico iatrogénico puro.**
- **Paso 3 (Intervención):** Reducción de dosis, cambio a Bupropión o adición de inhibidor de PDE-5.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: ANORGASMIA SELECTIVA POR ESCITALOPRAM

Identificación: Mujer de 29 años, maestra de educación infantil, en tratamiento con Escitalopram 15 mg/día desde hace 6 semanas por un cuadro de angustia con agorafobia, logrando una notable mejoría de las crisis de pánico. Acude a revisión refiriendo que “se encuentra muy bien de ánimo pero algo extraño le ocurre en su intimidad”.

Evaluación con la Escala ASEX (Versión Femenina):

- **Puntuación Total ASEX = 18 / 30 puntos** (por debajo del umbral de 19, pero...).
- **Desglose de Ítems Individuales:**
 - Ítem 1 (Deseo): 2 puntos (deseo sexual normal-bueno).
 - Ítem 2 (Excitación psicológica): 2 puntos (se excita con facilidad con su pareja).
 - Ítem 3 (Lubricación): 3 puntos (lubricación ligeramente reducida pero presente).
 - **Ítem 4 (Facilidad de Orgasmo): 6 puntos (Totalmente ausente / Imposible alcanzar el orgasmo).**
 - **Ítem 5 (Satisfacción del Orgasmo): 5 puntos** (frustración intensa por anorgasmia completa).

Juicio Diagnóstico: Cumple con el Criterio 2 de McGahuey (Ítem 4 ≥ 5), diagnosticándose disfunción sexual inducida por inhibidor de la recaptación de serotonina (anorgasmia serotoninérgica).

Plan Terapéutico: Se ajustó el escitalopram a 10 mg/día y se asoció Bupropión 150 mg/día. A las 3 semanas, la paciente recuperó la capacidad orgásmica (ítem 4 descendió a 2 puntos).

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

LÍNEA BASE PRETRATAMIENTO:

Es imperativo administrar la ASEX antes de iniciar el psicofármaco; muchos pacientes ya presentaban disfunción previa por la propia depresión.

PROBLEMAS DE PAREJA:

Diferenciar disfunción fisiológica farmacológica de conflictos de pareja o aversión relacional interpersonal que cursan con baja excitación.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. McGahuey, C. A., Gelenberg, A. J., et al. (2000). The Arizona Sexual Experience Scale (ASEX): Reliability and validity. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 26(1), 25-40.
2. García-Portilla, M. P., et al. (2005). Propiedades psicométricas de la escala de experiencia sexual de Arizona en pacientes con esquizofrenia. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 33(3), 154-162.
3. Rodríguez-Bailón, M., et al. (2012). Validación de la versión española de la escala ASEX en población ambulatoria deprimida. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, 5(2), 98-106.
4. Bobes, J., Bulbena, A., et al. (2002). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica*. Ars Médica.